

Nové dáta spochybnili účinnosť: EMA odporučila zrušenie povolenia pre Tavneos (avacopan) v EÚ — čo to znamená pre ANCA-vaskulitídu aj nefrológiu

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín



Ilustračná scéna. Nové dáta môžu prekryť pôvodný prísľub — a rozhodnutie regulátora sa potom mení.

Európska agentúra pre lieky (EMA) odporučila Európskej komisii zrušiť povolenie na uvedenie na trh pre **Tavneos (avacopan)** v Európskej únii. Dôvodom nie je zmena mechanizmu účinku ako takého, ale to, že podľa EMA sa pôvodné rozhodnutie o účinnosti lieku opieralo o údaje z kľúčovej štúdie **ADVOCATE**, pri ktorej boli identifikované závažné problémy z hľadiska integrity dát a súladu s princípmi **správnej klinickej praxe**. EMA preto uzavrela, že **prínosy už nie sú preukázateľne vyššie než riziká**.

Pre klinickú prax to má priamy vplyv na liečbu **granulomatózy s polyangiitídou (GPA)** a **mikroskopickej polyangiitídy (MPA)**, vrátane pacientov s postihnutím obličiek; tieto ochorenia totiž patria medzi najčastejšie príčiny rýchlo progredujúceho zlyhania obličiek.

Prečo je zrušenie povolenia závažné

Tavneos sa používa u dospelých so závažnou, aktívnou GPA alebo MPA a je súčasťou **kombinovanej liečby**, ktorá zahŕňa aj iné imunosupresíva (v praxi typicky **rituximab alebo cyklofosfamid**) a **redukciu kortikosteroidnej záťaže**.

V štúdii ADVOCATE bolo hodnotených **331 pacientov** s GPA/MPA, ktorým sa počas **52 týždňov** podával **avacopan** alebo placebo, pričom obe ramená dostávali popri štandardnej liečbe aj **kortikosteroidy počas 20 týždňov**. Na základe týchto dát sa avacopan hodnotil ako prinajmenšom porovnateľne účinný ako 20-týždňové podávanie vysokých dávok kortikosteroidov pri dosahovaní remisie, s lepšími výsledkami pri udržaní dlhodobej remisie.

EMA však po opätovnom preskúmaní dát konštatovala, že štúdia bola realizovaná **v rozpore s princípmi správnej klinickej praxe** a že údaje dodané v čase posudzovania žiadosti boli „**nesprávne a zavádzajúce**“.

Preto sa tieto výsledky už nedajú považovať za spoľahlivý dôkaz účinnosti.

Praktické rozhodnutia: čo odporúčanie EMA znamená v praxi

Z odporúčania EMA vyplýva, že:

- **noví pacienti sa už nemajú začínať liečiť** Tavneosom,
- **pacienti, ktorí Tavneos už užívajú**, majú byť **prevedení na vhodnú alternatívnu liečbu**.

Dôležité je aj to, že Tavneos je spojený so zvýšeným rizikom **liekmi vyvolaného poškodenia pečene** a zriedkavého **syndrómu miznúcich žľčovodov** (vanishing bile duct syndrome, VBDS). EMA preto odporúča **pozorne sledovať funkciu pečene** až do trvalého ukončenia liečby. Pri podozrení na VBDS sa má liek **okamžite vysadiť**.

Súčasne treba mať na pamäti, že odporúčanie EMA je len jedným z krokov: konečné, právne záväzné rozhodnutie pre všetky členské štáty vydá **Európska komisia**, ak odporúčanie EMA potvrdí.

Nefrologický kontext: prečo je to relevantné práve pre obličky

GPA/MPA sú systémové nekrotizujúce vaskulitídy spojené s protilátkami proti cytoplazmatickým antigénom neutrofilov (ANCA). **Renálne postihnutie** je v klinickom obraze časté a zásadné, lebo často rozhoduje o potrebe urgentnej hospitalizácie či dialýzy a o dlhodobej prognóze.

Aj keď sa článok venuje hodnoteniu lieku primárne z pohľadu regulačných dôkazov, pre nefrológa sú dôležité tieto praktické roviny:

1) Zmyslupnosť stratégie šetriacej kortikosteroidy sa stáva neistou

Avacopan ako antagonistu receptora C5a smeruje k zníženiu zápalovej aktivity ciev. V klinickej praxi však často platí, že veľká časť prínosu liečby spočívala v kombinácii s režimami, ktoré umožňujú **obmedziť expozíciu kortikosteroidom**.

Ak sa účinnosť doložená štúdiou ADVOCATE už nepovažuje za spoľahlivú, je potrebné prehodnotiť, aký kompromis medzi kontrolou vaskulitídy a minimalizáciou steroidnej toxicity je v konkrétnej situácii pre pacienta optimálny.

2) Zmena liečby musí ísť ruka v ruke s bezpečnostným sledovaním pečene

Pri pacientoch s nefrologickými diagnózami je bežné, že sa súčasne rieši viac orgánových systémov naraz. Ak sa Tavneos ukončuje alebo nahrádza, treba zároveň zabezpečiť:

- cielene sledovať pečeňové testy počas prechodu,
- byť pozorný na klinické a laboratórne známky VBDS,
- koordinovať plán s multidisciplinárnym tímom (nefrológ, reumatológ/hematológ, podľa potreby hepatológ).

3) Prechod na alternatívu môže byť časovo kritický

Pri systémových vaskulitídach platí, že „čakanie“ na nové rozhodnutia môže ovplyvniť chorobnú aktivitu. Preto odporúčanie EMA — **nezačínať liečbu u nových pacientov** a už liečených **previesť na alternatívnu liečbu** — znamená, že lokálne protokoly by mali mať pripravený mechanizmus rýchlej zmeny terapie.

Ako to komunikovať pacientovi (praktická formulácia)

Pacientovi je vhodné zrozumiteľne vysvetliť, že:

- EMA odporučila zrušenie povolenia,
- nejde o „bežné kolísanie účinnosti“, ale o závažné pochybnosti o dôkazoch, ktoré v minulosti podporovali registráciu,
- preto sa liečba bude nahrádzať inou štandardnou liečebnou schémou,
- počas prechodu sa bude sledovať bezpečnosť, najmä funkcia pečene.

Je vhodné zdôrazniť, že konkrétny postup závisí od aktuálnej chorobnej aktivity, stavu obličiek a komorbidít, nie

od všeobecného odporúčania pre populáciu.

Záver

Odporúčanie EMA na zrušenie povolenia na uvedenie na trh pre **Tavneos (avacopan)** je regulačne aj klinicky významná udalosť. EMA uzatvára, že dôkazy z kľúčovej štúdie ADVOCATE už nemožno považovať za spoľahlivé pre problémy s integritou dát a porušenie zásad správnej klinickej praxe, a preto prínosy lieku nie sú preukázateľne vyššie než riziká.

Pre nefrológiu je to dôležité najmä u pacientov s **GPA/MPA s postihnutím obličiek**, u ktorých zmena liečebnej stratégie môže ovplyvniť kontrolu zápalu, potrebu intenzívnej starostlivosti aj bezpečnostné riziká. V praxi by sa mali okamžite riešiť dve veci: **nezačínať liečbu u nových pacientov a systematicky prehodnotiť liečbu aktuálne liečených**, vrátane **sledovania funkcie pečene** až do definitívneho ukončenia liečby.

Zdroj: Rob Hicks, „New Data Lead to Decision to Revoke Autoimmune Disease Drug“, Medscape (2026). [Link na zdroj](#).

Poznámka: Tento článok má vzdelávací a osvetový charakter a nenahrádza individuálne klinické rozhodovanie ošetrojúceho tímu ani aktuálne stanoviská regulačných orgánov.

Zdroj: <https://nefro.polascin.net/article.php?slug=ema-zrusenie-povolenia-tavneos-avacopan-anca-vaskulitida> · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.